

ならびに作用を調節する一群の薬剤の総称である¹⁾。メディエーター遊離抑制薬のうち、sodium cromoglicate は長期使用によりアトピー型喘息患者の気道炎症を抑制する。ヒスタミン H₁ 受容体拮抗薬はアレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎を伴う喘息に有用性が期待できる。副作用として、眠気、倦怠感などの中枢神経作用に注意する必要がある。

トロンボキサン A₂ 合成阻害薬と受容体拮抗薬は、気道炎症を抑制して気道過敏性を改善させ、低下した粘膜線毛輸送能を改善させる。

Th2 サイトカイン阻害薬の主たる作用は、Th2 細胞からの IL-4、IL-5 産生抑制であり、喘息患者において気道粘膜の好酸球浸潤を抑制し、気道過敏性を改善する。

a ガイドラインにおける位置づけ

LTRA 以外の抗アレルギー薬は、喘息の長期管理薬の喘息治療ステップ 1~4 まで追加治療に記載されている¹⁾。LTRA 以外の抗アレルギー薬には、①メディエーター遊離抑制薬、②ヒスタミン H₁ 受容体拮抗薬、③トロンボキサン A₂ 合成阻害薬・受容体拮抗薬、④ Th2 サイトカイン阻害薬、が含まれる¹⁾。Th2 サイトカイン阻害薬は ICS の代替薬あるいは併用薬としての有用性が証明されている¹⁾。アレルギー性鼻炎を合併する患者に対しては、ヒスタミン H₁ 受容体

拮抗薬は鼻炎を改善させることによって喘息症状を改善させる可能性がある¹⁾と記載されている。アトピー咳嗽/喉頭アレルギーの治療薬としてヒスタミン H₁ 拮抗薬が、また、トロンボキサン A₂ 合成阻害薬と受容体拮抗薬、Th2 サイトカイン阻害薬が咳喘息の治療薬として記載されている²⁾。

b 実臨床における活用法

アレルギー性鼻炎は喘息との合併が多く、小児では喘息患者の 70% あるいはそれ以上、成人の喘息患者でも 40% 以上に合併が認められ、喘息発症の独立した危険因子であり、症状の増悪にも関連が深く、その関連は“one airway, one disease”として知られており¹⁾、治療薬として LTRA、ヒスタミン H₁ 受容体拮抗薬が有効である。

文 献

- 1) 日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン 2024 WG (監修): 喘息予防・管理ガイドライン 2024, 協和企画, 2024
- 2) 日本呼吸器学会咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 2025 作成委員会 (編): 咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 2025, メディカルレビュー社, 2025
- 3) 日本呼吸器学会難治性喘息診断と治療の手引き第 2 版 作成委員会 (編): 難治性喘息診断と治療の手引き 2023, メディカルレビュー社, 2023